

إِسْمُ الْمَرِيضِ رُبَاعِيًّا : كَمَالٌ سَلَامُهُ سَالِمٌ مُبَارَكٌ

العنوان : س

رقم التليفون : 01116744651

العمر(تاريخ الميلاد) : 02-02-1954 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
[11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: _____ التوقيع: _____

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم حمة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- /د ----- /د ----- /د.ا ----- /د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جھة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كمال سلامة سالم مبارك National ID: 25402022101663	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 كمل
 سلامة سالم مبارك
 قرية البرشين
 مركز البرشين - الجيزة
 ٢٥٤٠٢٠٢٢١٠١٦٦٣
 ٢٩٥١/٨٣
 LK7208682


 ٢٠٢٥/٨
 ٢٥٤٠٢٠٢٢١٠١٦٦٣
 ربة منزل
 انش
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٨/٢٣




Pat. Name: Kamal Salama Sayed	Pat. ID: 13514666
Date : 03/02/2025	

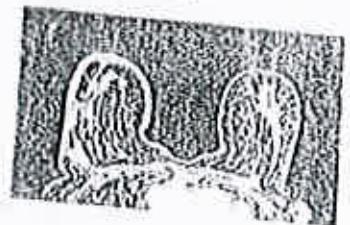
**BILATERAL DCE- MR MAMMOGRAPHY OF BOTH BREASTS USING 1.5T
BILATERAL DEDICATED 4 CHANNEL BREAST COIL:**

Technique:

- Axial T2 FSA, T1 FSA.
- Axial T2 FS & STIR.
- RT. Sagittal T2 FS.
- Diffusion W1 & apparent diffusion coefficient (ADC).
- Dynamic CE sequences, color coded map & Time intensity (TI) curve

RIGHT BREAST:

- o A partially defined irregular outline centrally located RT breast mass lesion measuring about 13 X 19 mm shows partially restricted diffusion with low ADC value (1.02×10^{-3}).
- o It shows inhomogeneous pattern of enhancement in contrast study. The time signal intensity curve shows initial strong enhancement with post initial washout.
- o Multiple retroareolar ectatic ducts with interstitial edema
- o Evidence of skin thickening with normal appearance of nipple/areola complex
- o axillary edema with no definite masses or LNs.....postoperative sequelae
- o Intact RT chest wall muscles



Pat. Name: Kamal Sahama Sayed
Date : 03/02/2025

Pat. ID: 13514666

LEFT BREAST:

- o prominent fibronodular glandular tissue with no focal lesions
- o No enlarged axillary lymph nodes seen.
- o Intact left chest wall muscles.
- o Non specific enlarged LT. axillary L.Ns.

CONCLUSION:

- o Right breast inhomogeneous enhancement mass with low ADC value and time signal intensity curve of malignant looking breast mass.....BIRAD IV.....for histopathological evaluation
- o Left breast is unremarkable

Thanks for referring.
Dr. INAS EL-FIKI, M.D.
Professor of radiodiagnosis,
Faculty of medicine

Patient Name : كمال سلامة منال مبارك / الامتنان
Patient No. : 25402022101663
Path No. : SR-1827/24
Sex : Male
Age : 70 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002612
Request Date : 04/12/2024
Verification Date : 16/12/2024
Financial Category : فئة الدولة - برنامج مار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data
Right breast mass

Nature of specimen
Slide & block revision

Gross examination

11 block & 6 16 slides labelled by (24002832) were received
IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench
Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), &
Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angiolysis: Positive
- * Perineural invasion: Positive
- * Margins: Free inked margin
- * Skin: Free
- * Lymph nodes: Positive (1/24)
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Moderate nuclear reaction in 80 % tumor cells (Allred score 7/8)
- * PR: Moderate nuclear reaction in 9% tumor cells (Allred score 4/8)
- * HER2: No membrane reaction in of tumor cells (score 0)
- * Ki 67: 10 % nuclear reaction of tumor cells

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 19/03/2025 09:38:24

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : كمال سلامة مبروك / الأمينة

Patient No. : 25402022101663

Path No. : SR-1827/24

Sex : Male

Age : 70 Y

Referring Doc :

Request No. : 13002612

Request Date : 04/12/2024

Verification Date : 16/12/2024

Financial Category : فئة التولية - برنامج التأمين

Department : Out Patient

Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis

Right breast mass, block & slide revision :

Invasive duct carcinoma, Grade II

-Free inked margin

-Free skin

-Lymph nodes : positive (1/24)

IPT:

* ER: Positive (score 7/8).

* PR: Positive (score 4/8).

* HER2: Negative (score 0).

* Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Signature

Dr.Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 19/03/2025 09:38:24

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الاول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadima - Cairo, Egypt



Patient Name : كمال سلامة سالم

Age : 70 Y

Referred by Prof. Dr : أ.د. إبراهيم عبد الرحمن

Contract : أ.د. إبراهيم عبد الرحمن

Nature of the Specimen : Wide Local Excision And Axillary Lymph Node Dissection

Clinical Diagnosis : Right Upper Quadrant Mass

Receiving Date : 02/11/2024

Code Number : 31749

PATHOLOGY REPORT

GROSS PATHOLOGY:

Two specimens were received designated as:

- 1- Wide local excision: Mammary tissue piece measured 9.5x7x5 cm covered by skin measured 9x6 cm showing no scars, marked by blue suture for lateral margin and short suture for superior margin. Serialing revealed an ill defined firm greyish white mass measured 2.7x2.5x1.3 cm located (0.6, 1.5, 2, 1.5, 3 and 2.5 cm) from (deep, skin, superior, inferior, medial and lateral) margins respectively. Rest of cut surface was fatty and unremarkable.
- 2- Axillary lymph nodes: Fibrofatty tissue piece measured 9x9 cm entangling thirty three nodules measured up to 2x1.5 cm infiltrated by...

HISTOLOGY:

Sections examined from the mass revealed invasive neoplastic growth made up of lobules of cohesive ductal malignant cells with moderate degree of cellular anaplasia with stromal desmoplasia. All skin margins were free of tumor tissue. The surrounding breast tissue showed evidence of gynecomastia. The examined lymph nodes showed positive metastatic deposition in one nodule, the rest showed reactive changes.

DIAGNOSIS:

- Invasive Duct Carcinoma (G2), Associated With Gynecomastia.
- No perineural Invasion
- Free Margins And Skin.
- Positive Deposits in (1/33) axillary nodes.
- pT2, pN1.

P.O.:

- 1- Detection of ER, PR, Her-2 And Ki-67 is now available on request.
- 2- 11 slides enclosed

Prof. Dr. Laila Moussa, PhD

Laila Moussa

Prof. Dr. Sahar Daoud, MD

Sahar Daoud

Patient Name: Kamal Salama Salem Mobarak	Date : 22/01/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 71 Year(s)
Medical ID: 3987/2024	Pat ID: 97107

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of right breast cancer.

I Chest:

- *Right breast shows OQ parenchymal distortion and mild skin thickening. Right axillary scarring is noted.*
- Bilateral pulmonary alternating areas of patchy parenchymal veiling and air lucency.
- Few tiny branching pulmonary nodular densities are seen at right upper lung lobe posterior segment.
- No pulmonary consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural, pleural thickening or masses.
- Cardiomegaly. Minimal pericardial effusion.

II Abdomen & pelvis:

- Enlarged liver with irregular outline showing homogenous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Enlarged spleen. No focal lesions.
- Normal CT appearance of the pancreas, kidneys (apart from prominent right extra renal pelvis with no significant back pressure changes), suprarenal glands, aorta and IVC.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- Subcentimetric left gastric and porta hepatis lymph nodes.
- No ascites.
- No sizable worrisome osseous lesions.
- Lucent focus of the right iliac wing.

Opinion:

Patient Name: Kamal Salama Salem Mobarak	Date : 22/01/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 71 Year(s)
Medical ID: 3987/2024	Pat. ID. 97107

Reported case of right breast cancer revealed:

- Bilateral pulmonary mosaic pattern with right upper lung lobe branching nodular densities, likely small airway disease. For clinical correlation.
- No sizable hepatic focal lesions.

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Prof. Menna Talla Hanafy, M.D.